



НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
(НСЗУ)

просп. Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073, тел.: (044) 426-67-77, (044) 290-06-91

E-mail: info@nszu.gov.ua, сайт: www.nszu.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 42032422

від _____ 20__ р. № _____

На № _____ від _____ 20__ р.

Надавачам медичних послуг
за списком

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виявлені в ході автоматичного моніторингу порушення умов договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій у частині внесення недостовірних або неповних даних, на підставі яких були сформовані звіти про медичні послуги

Національна служба здоров'я України (далі – НСЗУ), як центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, який у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, з метою належного виконання вимог Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (далі – Закон) та Положення про Національну службу здоров'я України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1101 (далі – Положення), повідомляє.

Статтею 19 Конституції України закріплено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з підпунктами 4, 5, 5¹ та 13 пункту 4 Положення НСЗУ відповідно до покладених на неї завдань:

укладає, змінює та припиняє договори про медичне обслуговування населення та договори про реімбурсацію;

здійснює заходи, що забезпечують цільове та ефективне використання коштів за програмою медичних гарантій;

проводить моніторинг виконання умов договорів про медичне обслуговування населення та про реімбурсацію у порядку, встановленому законодавством;

аналізує звітність надавачів медичних послуг щодо переліку та обсягу наданих медичних послуг за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.



Частиною першою статті 8 Закону визначено, що договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій укладається між Уповноваженим органом (НСЗУ) та закладом охорони здоров'я незалежно від форми власності чи фізичною особою – підприємцем, яка в установленому законом порядку одержала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що відповідають встановленим Кабінетом Міністрів України вимогам до надавача медичних послуг за програмою медичних гарантій, та має відповідати умовам закупівлі, специфікаціям до медичних послуг, а також враховувати визначений у програмі медичних гарантій обсяг забезпечення медичними послугами відповідно до потреб у межах кожного госпітального округу.

Відповідно до пункту 5 договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (далі – Договір), укладеного між НСЗУ та вами, моніторинг – комплекс заходів, які здійснюються замовником, щодо збору та аналізу інформації стосовно виконання надавачем умов Договору.

Згідно з положеннями пункту 5¹ Договору, автоматичний моніторинг – комплекс постійних автоматизованих заходів, заснованих на ризик-орієнтованому підході, які здійснюються з використанням інформаційно-комунікаційних систем, зокрема інформаційної системи замовника, для отримання інформації, необхідної для вирішення питання про проведення фактичного моніторингу, планування фактичного моніторингу, верифікації даних, що містяться в електронній системі охорони здоров'я (далі - Система), та застосування заходів, передбачених цим договором.

Відповідно до підпунктів 2, 3 та 13 пункту 19 Договору, надавач медичних послуг зобов'язується:

відповідати вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, у тому числі щодо доступності медичних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до законодавства, умовам закупівлі;

дотримуватися вимог законодавства, зокрема порядків надання медичної допомоги, табелів матеріально-технічного оснащення, в тому числі примірних, галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я, а також забезпечувати дотримання підрядниками зазначених вимог;

своєчасно вносити до системи повну та достовірну інформацію, в тому числі медичну документацію та звіти про медичні послуги, медичні записи, записи про направлення і рецепти у порядку, встановленому законодавством, з урахуванням положень специфікації.

Інформуємо, що НСЗУ проведено автоматичний моніторинг за пакетами медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» та «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня», за результатом якого виявлено факти внесення медичних записів, що містять

недостовірну та/або неповну інформацію про діагнози та/або проведені пацієнтам інтервенції, та/або необґрунтованого лікування пацієнта в умовах стаціонару.

Приклад 1. Внесення недостовірних медичних записів із застосуванням кодів інтервенцій 90665-00, 30023-00, 30023-01, які не містять основного та/або додаткових діагнозів, що вказують на наявність інфікованої, або ішемічної, або некротичної, або гангренозної рани чи виразки.

Відповідно до положень вступу Національного класифікатору медичних інтервенцій (далі - НК 026:2021) – НК 026:2021 гармонізований з Австралійським класифікатором медичних інтервенцій (Australian Classification of Health Interventions, ACHI), розробленим Австралійським консорціумом з розробки класифікацій (ACCD), та відповідає десятій редакції ACHI.

Відповідно до положень ACHI коди інтервенцій 90665-00, 30023-00, 30023-01 необхідно вказувати при інфікованій або ішемічній, або некротичній, або гангренозній тканині, або рані, або виразці, коли є клінічні показання для:

висічення шкіри та підшкірної клітковини (код 90665-00);

висічення м'яких тканин (код 30023-00);

висічення м'яких тканин включно з кісткою або хрящем (30023-01).

Проте, окремими надавачами медичних послуг у медичних записах систематично вказувались (66% медичних записів у ДСГ J08 та J08-01) вищезазначені коди інтервенцій **без наявності** основних та/або додаткових діагнозів, які підтверджують наявність інфікованої, або ішемічної, або некротичної, або гангренозної рани чи виразки, отже, такі медичні записи є неповними/недостовірними.

Приклад 2. Внесення недостовірних медичних записів із невідповідністю інтервенцій 90665-00, 30023-00, 30023-01 основному діагнозу.

Відповідно до стандарту 1916 Австралійських стандартів кодування, м'яка тканина визначається як тканина, яка з'єднує, підтримує або оточує інші структури і органи тіла. М'яка тканина включає м'язи, нерви, сухожилля, жирову тканину, кровоносні або лімфатичні судини, фасції і тканини навколо суглобів (синовіальна тканина) (тобто усі тканини, за винятком шкіри, підшкірної клітковини, хрящів і кісток). М'яка тканина часто описується як «глибока» внаслідок її анатомічного положення в організмі по відношенню до «поверхневої» тканини (шкіри і підшкірної клітковини). Тому інтервенція 30023-00 стосується висічення м'язів, нервів, сухожилля, жирової тканини, кровоносних або лімфатичних судин, фасцій і тканин навколо суглобів, а інтервенція 30023-01 стосується висічення вище сказаних структур включно з кісткою або хрящем.

Проте, у значній кількості медичних записів (29% медичних записів у ДСГ J08 та J08-01) зазначено інтервенцію, яка свідчить про висічення м'яких

(глибоких) тканин, а основний діагноз – про ураження поверхневих тканин, при яких інтервенції з кодами пункту 30023 не застосовуються.

Також, у значній кількості медичних записів зазначено основні діагнози, які або взагалі не потребують хірургічного лікування, або для обліку хірургічного лікування яких наявні інші специфічні інтервенції. Натомість, надавачі медичних послуг не обліковують специфічні інтервенції, які застосовуються при таких основних діагнозах, а неправомірно застосовують коди 90665-00 та/або 30023-00, та/або 30023-01, що призводить до віднесення пролікованого випадку у ДСГ з вищим ваговим коефіцієнтом.

Наприклад, основний діагноз «L71.1, Ринофіма», для обліку хірургічного лікування якого у НК 026:2021 передбачено інтервенцію «45653-00 Зрізання ринофіми». Інтервенція 45653-00 та основний діагноз L71.1 відносять медичний запис до ДСГ «J11 Інші операції на шкірі, підшкірній клітковині і молочних залозах» з ваговим коефіцієнтом 0,829. Проте, надавачі неправомірно застосовуючи код 90665-00 замість 45653-00 створюють ситуацію, за якої медичний запис щодо хірургічного лікування ринофіми відноситься до ДСГ «J08 Інші пересадки шкіри і видалення некротичних тканин» із більшим ваговим коефіцієнтом (1,842 проти 0,829).

Приклад 3. Внесення медичних записів щодо стаціонарного лікування за пролікованими випадками, які не підлягають стаціонарному лікуванню.

Серед медичних записів надавачів медичних послуг в межах ДСГ J08 – J11 наявна значна кількість медичних записів, які відповідно до зазначених у них основних та/або додаткових діагнозів та інтервенцій, а також віку пацієнта та відсутності хронічних станів не вказують на потребу стаціонарного хірургічного лікування.

Наприклад, при діагнозі «L60.0 Врослий ніготь» НК 026:2021 містить ряд специфічних інтервенцій для хірургічного лікування цього діагнозу:

Видалення нігтя пальця кисті (код 46516-01);

Клиновидна резекція врослого нігтя пальця кисті (код 46528-00);

Часткова резекція врослого нігтя пальця кисті (код 46531-00);

Повне висічення нігтьового ложа пальця кисті (код 46534-00);

Хірургічна обробка нігтя пальця стопи (код 47906-00);

Видалення нігтя пальця стопи (код 47906-01);

Клиновидна резекція врослого нігтя пальця стопи (код 47915-00);

Часткове висічення врослого нігтя пальця стопи (код 47916-00);

Повне висічення нігтьового ложа врослого нігтя пальця стопи (код 47918-00).

Відповідно до «Таблиці співставлення медичних послуг з кодами національного класифікатора НК 025:2021 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я» та/або національного класифікатора НК 026:2021 «Класифікатор медичних інтервенцій», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 03 квітня 2020 р. № 773, комбінація діагнозу

«L60.0 Врослий ніготь» та однієї чи декількох вищеперелічених інтервенцій відносить медичний запис до пакету медичних послуг «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах».

Проте, надавачі медичних послуг недостовірно зазначають коди інтервенцій (наприклад, 90665-00), які відносять такі медичні записи до стаціонарних випадків із більшою оплатою. При цьому, у переважній кількості подібних випадків відсутні додаткові діагнози та/або вік пацієнта, які вказували б на потребу лікування даної патології в стаціонарних умовах.

Додатково нагадуємо, що НСЗУ листом від 26.09.2024 № 32947/11-15-24 інформувала надавачів щодо обов'язковості належного кодування всіх інтервенцій та діагнозів у межах стаціонарного лікування з використанням національних класифікаторів НК 025:2021 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я» та НК 026:2021 «Класифікатор медичних інтервенцій».

Повідомляємо, що відповідно до пункту 27 Договору у зв'язку із виявленням у ході автоматичного моніторингу порушень умов Договору, а саме внесення Вами неповних/недостовірних медичних записів, що призвело до збільшення суми оплати за звітами про медичні послуги за попередні звітні періоди, буде здійснено перерахунок. Перелік медичних записів, які підлягають перерахунку – у додатку до цього листа.

Додатки:

1. Лист НСЗУ від 26.09.2024 № 32947/11-15-24 «Інформування щодо кодування діагнозів/інтервенцій у електронних медичних записах про надання медичних послуг в стаціонарних умовах» на 2 арк. в 1 прим.
2. Перелік неповних/недостовірних медичних записів, які підлягають перерахунку, у форматі Excel в 1 прим.

Голова

Наталія ГУСАК